

УДК: 618.11-006

А.К.Адилышин, Т.М.Пахомова

Северо-Казахстанский облонкодиспансер

## «Гигантская киста» яичника

Согласно литературным данным [2], доброкачественные опухоли яичников встречаются в 34% случаев, и по классификации ВОЗ выделяют 11 разновидностей: параовариальные, воспалительные, поверхностные эпителиальные, единичные, множественные и т.д. В доступной литературе мы не нашли описания «гигантских кист» яичников, только Г.С. Мурзабекова с соавт. [3] сообщают о случае дермоидной кисты размерами 15х10х10, весом 1кг 50 г у беременной с беременностью 39 недель, осложнившей течение беременности. Поэтому мы посчитали интересным и полезным для практических врачей изложить наше наблюдение, а также поделиться возможностями дифференциальной диагностики между асцитом и большой кистой брюшной полости на этапе физикального обследования. Основным симптомом этих 2-х состояний является жалоба на распирающую боль в животе и увеличение живота.

Больная Ю.Н.Л., 36 лет, поступила в онкодиспансер 08.06.2009 г. с жалобами на слабость, колюще-распирающую боль в животе. Из анамнеза - осмотрена гинекологом 2 г. назад, вопрос об опухолевом образовании не поднимался. При последнем обращении к врачу в декабре 2008 г. отмечает увеличение живота в объеме, к гинекологам в течение 2-х лет не обращалась. С марта 2009 г. отмечает нарастающую слабость и распирающую боль в животе и в области таза. В областном онкодиспансере обследована амбулаторно, госпитализирована для оказания специализированной помощи. Страдает хроническим пиелонефритом, последние 2 года артериальной гипертензией, перенесла оперативное лечение по поводу панариция на правой ноге; аллергические реакции, гемотрансфузии отрицает. Менструации с 13,5 лет, по 3-4 дня, через 24-26 дней. Гинекологический анамнез - не замужем, беременностей, аборт не было.

Состояние при поступлении средней тяжести, отеков нет, периферические лимфоузлы не увеличены. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. Органы кровообращения - тоны сердца приглушены, ритм правильный, систолический шум на верхушке. Пульс 86 ударов в мин, ритмичный. АД - 120/80 мм рт. ст. В легких дыхание жестковатое, в нижних отделах - ослабленное везикулярное, хрипов нет. ЧД - 18 в 1 мин. Органы пищеварения - язык влажный; живот при поверхностной пальпации мягкий, увеличен за счет образования, заполняющего все этажи брюшной полости. Симптом поколачивания поясницы отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное, моча светлая. Стул оформленный, темного цвета.

Гинекологический статус: наружные половые органы без особенностей, invirgo. Perrectum - из таза образование овоидной формы, увеличено до 38 недель беременности, мягкой консистенции, неподвижное, безболезненное при пальпации. Придатки не пальпируются. Своды укорочены. Выделений нет. Предварительный клинический диагноз - Cystovagii. Ки-стома яичника. Анемия.

Результаты лабораторного обследования:

а) общий анализ крови - гемоглобин - 55 г/л, эритроциты -  $2,5 \times 10^{12}/л$ , цп-0,66, тромбоциты -  $275,0 \times 10^9/л$ , лейкоциты -  $4,0 \times 10^9/л$ , нейтр. п/яд- 8, сег/яд-58, мон- 1, лимфоциты - 33, СОЭ - 50 мм/час; анизоцитоз - не резко выраженный, пойкилоцитоз - слабо выраженный, ги-похромия - не резко выраженная;

б) общий анализ мочи - желт., мут., уд. вес - 1020, кисл., белок - отр., глюкоза - отр., ураты - сплошь;

в) биохимический анализ крови - общий белок - 82 г/л, альбумин - 54,9%, глобулин - 45,1%, из них альфа-1 - 4,3%, альфа-2 - 9,9%, бета - 11,2%, гамма - 19,7%; СРБ-3(+++), мочевины - 5,2 ммоль/л, креатинин - 0,053 ммоль/л, общий билирубин - 11,3 ммоль/л, АлаТ - 0,11 мкмоль/л, АсаТ - 0,11 мкмоль/л, холестерин - 3,5 ммоль/л, глюкоза - 6,1 ммоль/л.

Результаты инструментального обследования:

а) эзофагогастродуоденоскопия - деформация желудка, сдавление извне; дуоденогастральный рефлюкс желчи;

б) ирригоскопия - колит;

в) маммография - без патологии;

г) УЗИ гениталий и брюшной полости - 29.05.2009 г. киста яичника, 02.06.2009 г. по программе «Здоровье» исследованы матка, эндометрий, правый и левый яичники, мочевой пузырь, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки с ЧЛС, селезенка, щитовидная железа. Заключение: структурной патологии не выявлено; 06.06.2009 г. в областной больнице - в поза-дипеченочном пространстве, в боковых отделах и внизу живота - экзонегативные участки, соответствующие свободной жидкости. Заключение: Признаки асцита значительной степени выраженности. 09.06.2009 г. онкодиспансер - в брюшной полости, занимая малый таз, кистозно-солидное образование больших размеров;

д) рентгенография органов грудной клетки - без патологии;

е) ЭКГ - ритм синусовый, синусовая тахикардия, отклонение электрической оси сердца влево. ЧСС-120 в 1 мин. Блокада передней ветви левой н/пучка Гиса; и) МРТ органов брюшной полости - На МР-томограммах определяется кистозное образование больших размеров, расположенное в малом тазу и распространяющееся в брюшную полость до ворот печени, оттесняющее петли кишечника к передней брюшной стенке, гиперинтенсивное на T1ВИ и T2ВИ. Образование имеет капсулу и состоит из нескольких камер, с наличием гиперинтенсивных на T2ВИ включений внутри образования. Печень размерами 152\*103\*89мм, контуры четкие, ровные, структура однородная. Желчный пузырь размерами 38\*24 мм, не деформирован, желчные протоки несколько расширены. Селезенка размерами 138\*53 мм, однородной структуры. Положение почек обычное, форма их правильная, контуры четкие, ровные. Заключение: кистозное образование брюшной полости и малого таза.

Консультации специалистов:

а) уролог - без патологии;

б) гематолог - симптоматическая анемия тяжелой степени;

в) терапевт - симптоматическая ЖДА тяжелой степени, миокардиодистрофия, синусовая тахикардия, НЦД по гипертоническому типу, хронический бронхит вне обострения, ДН 0; дуоденогастральный рефлюкс, варикозное расширение вен нижних конечностей;

г) сосудистый хирург - варикозная болезнь, варикозное расширение вен н /конечностей. ХВН 2ст.

17.06.2009 г. произведена нижнесрединная лапаротомия, удаление придатков матки слева, рассечение спаек, дренирование. Свободной жидкости в брюшной полости не обнаружено. При ревизии брюшной полости образование припаяно к передней брюшной стенке, париетальной брюшине, сальнику на всех этажах брюшной полости. Произведена эвакуация жидкости из образования в виде темного кофе в количестве 30,0 литров. Образование отделено от брюшной стенки, петель кишечника, сальника. Образование выделено в рану. При дальнейшей ревизии в верхнем этаже в желчном пузыре выявлен камень, занимающий весь пузырь, плотный. После консультации с зав. хирургическим отделением рекомендовано удаление в общей лечебной сети. Наложены зажимы на воронкообразную связку слева и образование удалено. Матка и правый яичник не изменены. На разрезе образование камерное, стенки ровные, гладкие.

Патолого-гистологическое исследование удаленного образования: в препаратах из левого яичника доброкачественная муцинозная опухоль яичника эндометриального типа; в трубе просвет сужен, полнокровие сосудов, в жировой ткани полнокровные сосуды и участки кровоизлияния.

Цитологическое исследование материала: в содержимом из кисты межфолликулярное вещество, голые ядра, макрофаги.

Послеоперационный период протекал обычно, проводилась патогенетическая адекватная терапия: трансфузии эритроцитарной массы в связи с анемией.

В удовлетворительном состоянии пациентка выписана на амбулаторное лечение по месту жительства под наблюдением гинеколога.

Данный случай соответствует муцинозным эпителиальным опухолям, описываемым Я.В. Бохман [1] - «имеют вид кисты ... часто очень больших размеров ... многокамерные ... имеют ножку».

В качестве физикального метода исследования, дающего возможность различения асцита и кисты брюшной полости мы предлагаем использовать перкуссию с целью определения границы тупости из-за жидкостного образования в горизонтальном положении на спине и на боку, от пупка вбок при положении плессиметра параллельно срединной линии тела, и от пупка вниз к лобку до появления тупости в горизонтальном и вертикальном положении тела [4] при положении плессиметра перпендикулярно к белой линии живота. При наличии свободной жидкости в брюшной полости уровень тупости будет меняться, чего не будет при инкапсулированной жидкости в кистозном образовании.

## Список литературы

1. Бохман Я.В. - *Руководство по онкогинекологии*. - М.: Медицина, 1989.
2. Вишневецкая Е.Е. *Справочник по онкогинекологии*. - Минск Беларусь, 1980.
3. Мурзабекова Г.С., Сапарбекова А.З., Мамаева А.М., Осси Н.А. // *Медицинский журнал Казахстана*. - 1999. - №2(5). - С. 95-96.
4. Струтинский А.В. и соавт. *Основы семиотики заболеваний внутренних органов*. - М.: Медпресс-ин-форм, 2011